

## ARTRITIS REUMATOIDE

*Boris A. Blanco-Cáceres, Fernando Lozano, Sandra P. Chinchilla*

### INTRODUCCIÓN

La Artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune crónica que puede afectar a cualquier órgano, pero tiene especial predilección por el aparato locomotor. Suele afectar más a menudo a mujeres de mediana edad.

El abordaje terapéutico ha cambiado mucho en la última década con el objeto de controlar la inflamación articular y de esta forma disminuir el daño estructural y la discapacidad asociada.

El tratamiento de la AR se basa en terapias inmunomoduladoras o inmunosupresoras que buscan controlar la inflamación. En algunas ocasiones estos pacientes presentan brotes de la enfermedad o acontecimientos adversos derivados del tratamiento, demandando consulta en los servicios de urgencias.

A continuación mencionaremos algunas de las complicaciones más frecuentes y el abordaje sugerido en urgencias. Es importante tener en cuenta que ante cualquier evento que suponga actividad de la enfermedad se debe remitir al paciente a su reumatólogo habitual para completar el manejo terapéutico y el ajuste del tratamiento de fondo si fuera necesario.

### MANIFESTACIONES ARTICULARES

#### MONOARTRITIS

##### Introducción

A pesar de la naturaleza poliarticular de la AR, en ocasiones los pacientes consultan por sintomatología monoarticular sobre articulación nativa. En estos casos, en primer lugar se debe descartar el origen infeccioso por el riesgo que supone. Las articulaciones más afectadas suelen ser rodillas y hombros.

##### **Anamnesis**

Preguntar por síntomas sistémicos como fiebre, tiritona o malestar general. La afectación articular puede llegar a limitar las actividades cotidianas. El dolor es característicamente inflamatorio y persiste en reposo. Averiguar el tiempo de evolución de la sintomatología, precipitantes como abandono de la medicación, (el abandono de la medicación te haría sospechar un brote de la AR monoarticular, pero no una artritis infecciosa) traumatismo, heridas, instrumentación oral, digestiva, o urinaria recientes.

##### Diagnóstico

##### **Exploración Física**

La articulación comprometida estará tumefacta, caliente y eritematosa, con importante limitación funcional para los movimientos activos y pasivos. Buscar soluciones de continuidad cutáneas (a menudo presentes en compromiso de articulaciones en zonas de apoyo).

##### **Pruebas Complementarias**

- **Artrocentesis.** Siempre que sea posible se debe obtener muestra del líquido sinovial (LS) mediante artrocentesis. Cursar análisis del LS (glucosa, proteínas y celularidad), enviar muestra a Microbiología.

- **Hemograma** con fórmula y recuento leucocitario.
- **Bioquímica** glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOP, GPT y reactantes de fase aguda (PCR, VSG)
- **Coagulación** básica si toma ACOs, HBP o dicumarínicos.
- **Sistemático y sedimento de orina.** Si sospecha o clínica miccional
- **Radiografía** de la articulación afectada.
- **Hemocultivos y urocultivos.** Cursar si se sospecha causa infecciosa, previos al inicio del tratamiento antibiótico, incluso en ausencia de fiebre.

### Tratamiento

En los casos en los que la artritis sea sugerente de brote inflamatorio pautar corticoides orales o parenterales (<30 mg/día de prednisona en dosis descendentes) y asociar AINEs si el perfil del paciente lo permite (no aconsejados en pacientes mayores o con enfermedad renal). La dosis debe ser individualizada, articulaciones pequeñas podrían beneficiarse de dosis < 15 mg/día. La infiltración local de corticoide con anestésico (P.ej. acetónido de triamcinolona 40mg + Lidocaína) es una opción viable y de fácil acceso en articulaciones grandes como la rodilla o el hombro.

Si la sospecha infecciosa es alta, iniciar tratamiento antibiótico empírico con cobertura para gram positivos y gram negativos, en función del perfil de cada paciente (P. ej.: Cloxacilina + Ceftriaxona). Solicitar ingreso hospitalario para continuar tratamiento parenteral.

Cuando un paciente reciba tratamiento con Fármacos modificadores de la enfermedad (FAMEs) convencional o biológico este siempre debe suspenderse de forma temporal y comunicar al reumatólogo habitual. Es importante verificar la medicación que el paciente viene tomando.

## **BROTE POLIARTICULAR**

### Introducción

Cuando un paciente acude por artritis en cuatro o más articulaciones hablamos de un brote poliarticular. En esta situación el paciente presenta incapacidad funcional afectando claramente su calidad de vida. Estos pacientes probablemente requieran un ajuste del tratamiento por parte de su reumatólogo.

### **Anamnesis**

Preguntar por síntomas sistémicos como fiebre, tiritona o malestar general. En un brote poliarticular los pacientes se ven incapacitados para tareas cotidianas básicas como vestirse o peinarse, esto nos orientará sobre la gravedad del cuadro. Averiguar el tiempo de evolución de la sintomatología y precipitantes como abandono de la medicación o infecciones recientes.

### Diagnóstico

#### **Exploración Física**

Las articulaciones comprometidas estarán tumefactas, calientes y eritematosas, asocian limitación funcional para los movimientos activos y pasivos. Las articulaciones que se afectan con más frecuencia son las pequeñas (manos o pies), hombros y rodillas. Es de ayuda para el manejo posterior, reseñar en la historia el número de articulaciones tumefactas y dolorosas.

#### **Pruebas Complementarias.**

- **Hemograma** con fórmula y recuento leucocitario.
- **Bioquímica** glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa y reactantes de fase aguda (PCR, VSG).

- **Coagulación** básica si toma ACOs o HBP o dicumarínicos.
- **Sistemático** y sedimento de orina.
- **Radiografía de tórax** anteroposterior y lateral.
- De encontrarse elevados los reactantes de fase aguda, descartar otras posibles causas como infecciones respiratorias, digestivas, urinarias, etc.

### Tratamiento

Los pacientes se beneficiarán de corticoides orales o parenterales en función de la afectación, no existen pautas establecidas pero se puede pautar corticoide parenteral y luego oral (equivalente a <30 mg/día Prednisona, en pauta descendente) hasta control por su reumatólogo.

- **Articulaciones pequeñas: prednisona 15mg/día pauta descendente.** El número de articulaciones comprometidas y el tamaño de estas orientará a la pauta de corticoides a utilizar, en el caso de las articulaciones pequeñas en general se controlan con <15 mg/día en pauta descendente.
- **Articulaciones pequeñas y grandes: prednisona 30mg/día.** Aquellos casos con importante compromiso funcional, sistémico y afectación de grandes y pequeñas articulaciones podrían beneficiarse de una dosis parenteral de corticoides y al alta corticoides orales <30 mg/día en pauta descendente hasta control por Reumatología.

Se pueden asociar AINEs si el perfil del paciente lo permite.

## **MANIFESTACIONES EXTRAARTICULARES**

A continuación reseñamos algunas manifestaciones que se pueden presentar en pacientes con AR.

### Cutáneas

- Nódulos reumatoides en zonas de roce, no precisan tratamiento urgente.
- Reacción psoriasiforme en pacientes con tratamiento biológico (antiTNF), suspender tratamiento y solicitar valoración por Reumatología.
- Púrpura, pioderma gangrenoso, en relación a vasculitis reumatoidea.
- Fenómeno de Raynaud.

### Oculares

Queratoconjuntivitis seca, epiescleritis (ojo rojo no doloroso), escleritis (ojo rojo doloroso y fotofobia). Requieren valoración por Oftalmología si:

- Disminución de agudeza visual.
- Dolor ocular moderado-severo.
- Primer episodio de ojo rojo doloroso con empeoramiento progresivo.

### Pulmonar

Pueden estar asociadas a la propia enfermedad, infecciones intercurrentes o al tratamiento empleado.

### Compromiso pleural

Pleuritis, líquido pleural con características de exudado, poca celularidad, LDH y ADA elevados, FR positivo. En general no requieren tratamiento salvo el de la enfermedad de base, se debe individualizar. Es importante descartar otras causas como la cardiogénica.

### Enfermedad pulmonar intersticial

Curso clínico variable, desde asintomática hasta rápidamente progresiva con necesidad de soporte e ingreso hospitalario. Radiográficamente presenta patrón retículo-nodular.

### Cardiovascular

La AR es un factor independiente de riesgo cardiovascular por lo que los eventos cardiovasculares están incrementados en estos pacientes.

**Pericarditis:** pueden presentar derrame pericárdico, la mayoría de forma asintomática, raramente evolucionan a taponamiento cardíaco. Requiere manejo conjunto Reumatología - Cardiología.

### Hematológicas

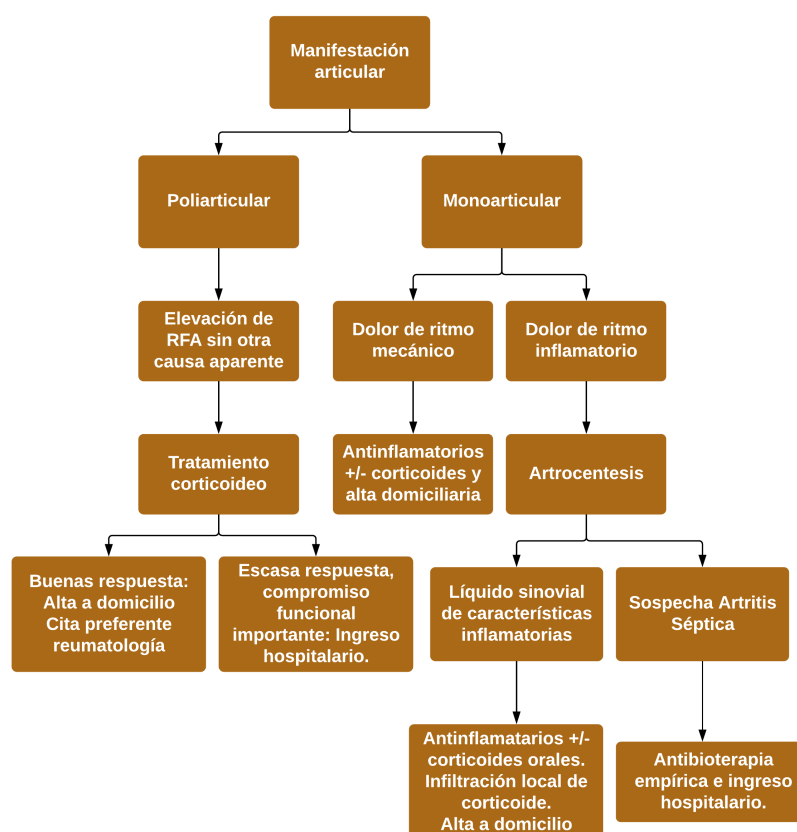
Los pacientes presentan anemia de trastornos crónicos y trombocitosis en relación al proceso inflamatorio de base. El Síndrome de Felty cursa con neutropenia, esplenomegalia, en un/a paciente con AR seropositiva de larga evolución.

No olvidar efectos adversos de los medicamentos, en especial en aquellos pacientes que presenten deterioro agudo de la función renal ya que algunos fármacos modificadores de la enfermedad pueden producir citopenias por toxicidad.

### Infecciones

Los pacientes con AR y otras enfermedades inflamatorias/autoinmunes tienen un riesgo aumentado de infecciones bacterianas como neumonía, infecciones de piel y partes blandas, entre otras que pueden comprometer la vida. El tratamiento de base que se emplea en la AR (Glucocorticoides, FAMEs biológicos y sintéticos) incrementa este riesgo, y en muchos casos las infecciones cursan de forma paucisintomática y con poca expresividad sistémica. De constatarse un proceso infeccioso el tratamiento con FAMEs debe ser suspendido, pudiendo mantener el tratamiento con corticoides a dosis bajas. Es importante informar al especialista en Reumatología sobre la suspensión del tratamiento. Ante todo primará la estabilidad clínica y hemodinámica del paciente.

## MANIFESTACIONES ARTICULARES



## BIBLIOGRAFÍA

- Alperi López M. Artritis Reumatoide. Clínica y Diagnóstico. En: Tornero J, Blanco Garcia FJ, Directores. Tratado de enfermedades Reumáticas de la SER. España: Editorial Panamericana; 2018. p. 399-406.
- Bouros D, Pneumatikos I, Tzouveleakis A. Pleural involvement in systemic autoimmune disorders. Respiration 2008; 75:361
- Turesson C, O'Fallon WM, Crowson CS, Gabriel SE, Matteson EL. Extra-articular disease manifestations in rheumatoid arthritis: incidence trends and risk factors over 46 years. Ann Rheum Dis. 2003;62(8):722.
- Guedes C, Bianchi-Fior P, Cormier B, Barthelemy B, Rat AC, Boissier MC. Cardiac manifestations of rheumatoid arthritis: a case-control transesophageal echocardiography study in 30 patients. Arthritis Rheum. 2001;45(2):129.
- Smolen JS, Aletaha D, Bijlsma JW, Breedveld FC, Boumpas D, Burmester G, Combe B, Cutolo M, de Wit M, Dougados M, Emery P, Gibofsky A, Gomez-Reino JJ, Haraoui B, Kalden J, Keystone EC, Kvien TK, McInnes I, Martin-Mola E, Montecucco C, Schoels M, van der Heijde D, T2T Expert Committee. Treating rheumatoid arthritis to target: recommendations of an international task force. Ann Rheum Dis. 2010;69(4):631. Epub 2010 Mar 9.
- Doran MF, Crowson CS, Pond GR, O'Fallon WM, Gabriel SE. Frequency of infection in patients with rheumatoid arthritis compared with controls: a population-based study. Arthritis Rheum. 2002;46(9):2287.